

Abordagem da constipação



ROTINA CLÍNICA

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
<u>Type 3</u>		Like a sausage, but with cracks on the surface
<u>Type 4</u>		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges (passed easily)
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces (entirely liquid)

Introdução

- ◆ **Definição:** “Dificuldade evacuatória persistente ou sensação de evacuação incompleta e/ou evacuações infrequentes”;
- ◆ Critérios de **ROMA IV** para constipação funcional incluem:
- ◆ **Menos de 03 evacuações por semana;** Fezes tipo Bristol I ou II (fezes ressecadas ou duras) em mais de 25% das evacuações; Esforço evacuatório; Sensação de evacuação incompleta; Sensação de obstrução ou bloqueio anorretal; Necessidade de manobra manual para facilitar a evacuação.

Introdução

- ◊ Racional envolve **redução do número de evacuações (< 3 por semana) + alteração evacuatória** (fezes ressecadas; esforço, desconforto, evacuação incompleta, entre outros achados);
- ◊ **Epidemiologia:** Prevalência em 15-20% da população; mais comum em mulheres, crianças e idosos; A história familiar favorece a constipação nos demais membros da família; Maior incidência em indivíduos com baixo nível socioeconômico.

Etiologias

- ◆ **Diversas, podemos citar:**
- ◆ Distúrbios neurológicos ou endócrinos;
- ◆ Problemas psicossociais;
- ◆ Doenças do cólon ou disfunções do assoalho pélvico;
- ◆ Medicamentos;
- ◆ Idiopática (funcional);
- ◆ A ingesta inadequada de fibras e água é um dos fatores contribuintes.

Neurogenic disorders
Peripheral
Diabetes mellitus
Autonomic neuropathy
Hirschsprung disease
Chagas disease
Intestinal pseudoobstruction
Central
Multiple sclerosis
Spinal cord injury
Parkinson disease
Irritable bowel syndrome
Drugs
See separate table

Non-neurogenic disorders
Hypothyroidism
Hypokalemia
Anorexia nervosa
Pregnancy
Panhypopituitarism
Systemic sclerosis
Myotonic dystrophy
Idiopathic constipation
Normal colonic transit
Slow transit constipation
Dyssynergic defecation

Analgesics
Anticholinergics
Antihistamines
Antispasmodics
Antidepressants
Antipsychotics
Cation-containing agents
Iron supplements
Aluminum (antacids, sucralfate)
Barium
Neurally active agents
Opiates
Antihypertensives
Ganglionic blockers
Vinca alkaloids
Calcium channel blockers
5HT3 antagonists

Anamnese

- ❖ Avaliar todas as **características das evacuações e do bolo fecal** (frequência, esforço, volume, sensação de evacuação completa ou não, calibre, consistência e formato das fezes – escala de Bristol, necessidade de manobras manuais);
- ❖ Avaliar **dieta** (especialmente consumo de fibras), **ingesta hídrica**, **atividade física**, medicamentos de uso contínuo e história de abusos físicos e sexuais; Deve-se atentar para mudanças no estilo de vida e comportamento do paciente.

Anamnese e Exame Físico

- ◇ Se duração superior a 3 meses = Constipação crônica;
- ◇ Deve-se pesquisar ativamente a presença de sinais de alarme e medicamentos em uso domiciliar;
- ◇ **Exame Físico:**
- ◇ Em geral, é normal;
- ◇ Podemos encontrar (raramente) presença de fecaloma palpável em FIE;
- ◇ Avaliar presença de peristaltismo de luta, distensão abdominal e hipertimpanismo à percussão (diferencial para oclusão intestinal).

→ **Patients with alarm features or age ≥ 45 years**

Alarm features include the following (🔗 algorithm 1):

- Hematochezia or heme-positive stool
- Iron deficiency anemia
- Clinically significant weight loss (>5 percent of usual body weight over 6 to 12 months)
- New onset of unexplained constipation
- Obstructive symptoms
- Family history of colorectal cancer or inflammatory bowel disease

Sinais de alarme:

- Sangramento retal;
- História familiar de doença inflamatória intestinal ou neoplasia colorretal;
- Presença de sangue oculto nas fezes;
- Anemia ferropriva;
- Constipação em pacientes idosos;
- Constipação de início recente, sem fator causal;
- Perda ponderal.

Initial assessment with history, examination, and laboratory testing*

Does the patient have any of the following?

- Age ≥ 45 years
- Alarm features:
 - Hematochezia or heme-positive stool
 - Iron deficiency anemia
 - Clinically significant weight loss ($>5\%$ of usual body weight over 6 to 12 months)
 - New onset of unexplained constipation
 - Obstructive symptoms
 - Family history of colorectal cancer or inflammatory bowel disease

Yes

No

Perform colonoscopy

Was a cause of constipation identified? ¶

Abordagem

- ◆ **Medidas comportamentais/gerais:**
- ◆ Ingesta hídrica: 25 a 30 mL/kg/dia (70 kg = 2100 mL);
- ◆ Ingesta de fibras: 20 to 35 g/dia;
- ◆ Orientações: Tentar defecar após as refeições, aproveitando assim o aumento de motilidade colônico pós-prandial; Isto é particularmente importante pela manhã, quando a atividade motora do cólon é mais elevada;
- ◆ Atividade física regular; Treinamento evacuatório; Postura adequada.



Abordagem

- ◆ **Medicamentos (complementares na abordagem):**
- ◆ Psyllium** (fibra solúvel vegetal), Metilcelulose e Policarbofila (“bulk-forming laxatives”).
- ◆ Agentes osmóticos (Exemplos: Polietilenoglicol, Lactulose, Macrogol): Água e os eletrólitos permanecem no lúmen intestinal devido ao efeito osmótico.
- ◆ Agentes estimulantes/irritativos (Exemplos: Bisacodil e Picosulfato de sódio): Promovem alteração do transporte de eletrólitos pela mucosa intestinal e aumentam a atividade motora intestinal.



Abordagem

- ◊ Brasil: Óleo mineral pode ser utilizado com objetivo de facilitar a interface entre os componentes hidrofóbicos e hidrofílicos da massa fecal (“Laxante amaciante”);
- ◊ Deve-se evitar óleo mineral em pacientes disfágicos e idosos, em razão do risco de broncoaspiração e pneumonia lipoídica (pneumonite pela aspiração de lipídios - O tratamento principal é a suspensão imediata do óleo mineral);
- ◊ Nos EUA, não é utilizado pela via oral.

Abordagem

- ❖ Pacientes com **constipação grave e refratária** podem ser abordados com:
- ❖ Supositórios: Para o tratamento da disfunção defecatória, podem ser utilizados supositórios (glicerina ou bisacodil), pois podem ser eficazes na liquefação das fezes;
- ❖ Desimpactação: Pacientes com impactação fecal (um volume sólido e imóvel de fezes no reto) devem inicialmente ser desimpactados, começando com a fragmentação manual, se necessário. Depois de feito isso, um enema com óleo mineral ajudará a amolecer as fezes e fornecer lubrificação.

Prescrição

- ◆ Lactulose (667 mg/mL): Tomar 15 a 20 mL, VO, de 6/6h. Ajustar dose conforme resposta;
- ◆ +/-
- ◆ Bisacodil 5 mg/comprimido: Tomar 01 a 02 comprimidos, VO, uma vez ao dia. Ajustar dose conforme resposta;
- ◆ Ou
- ◆ Picossulfato de sódio: Tomar 10 a 20 gotas VO 1x/dia. Ajustar dose conforme a resposta.

- ◆ Óleo mineral: Dose inicial de 1 colher de sopa, VO, de 12/12 horas. Ajustar dose conforme a resposta. Evitar em idosos pelo risco de aspiração.

Referências

- ◆ Etiology and evaluation of chronic constipation in adults – UpToDate;
- ◆ Management of chronic constipation in adults – UpToDate.